جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : سهير السيد عبدالوهاب البزاوي
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** السيده زينب **العنوان :** ..
رقم البطاقة : 26506171601401 **رقم التليفون :** 01153459012 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 17-06-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سهير السيد عبدالوهاب البزاوى
National ID: 26506171601401

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





٠١١٥٢٤٥٩٠١٢
٠١١٢٠١٩٢٢٥٣

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

صحة

07/08/2026

MDT FORM

Name:	Sohir, السيد عبدالوهاب الزراوي	**MRN:**	10831
Age:	61 Y	**ID:**	
Menopausal Status:		**Phone:**	01153459012
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	+VE
CO Morbidity:	FREE	**Reason Of MDT:**	NEW CASE

Clinical Data:

BX: RT IDC G2 /// LT FIBROADENOMA SURROUNDED WITH UDH

ER: 8\8 **PR:** 7\8 **HER2:** 1 **KI67:** 15

Sonomammography:

SM
RT BREAST UOQ POST THIRD IRREGULAR SPICULATED MASS WITH DISTORTION
NO MICROCALCIFICATIONS
UOQ ANT. THIRD CIRCUMSCRIBED OVAL MASS
10 OCLOCK POST THIRD 5 CM DEEP TO SKIN IRREGULAR SPICULATED HYPOECHOIC SOLID MASS 1.8*1.6 CM
NON SPECIFIC LN
LT BREAST UIQ OVAL MASS LESIONS 0.6*0.4 CM , 0.7*0.4 CM & 0.8*0.4 CM
NON SPECIFIC LN

Mets Workup:

CT CAP FREE

History:

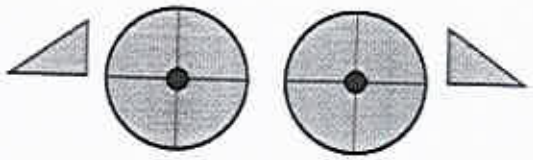
Recommendations:

FOR RT BCS+SLNB

MDT Outcome & Plan

Review mammosonography films at surgery clinic then proceed with Rt WLE & SLNB as well as Lt lumpectomy.

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د شيماء لاشين	د امنيه عويس				

Name: سهير السيد عبدالوهاب البزاوي **MR. :** 10831	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 61-year-old individual with a clinical history of postoperative radiotherapy following upfront breast-conserving surgery and sentinel lymph node biopsy. Pathology demonstrated invasive ductal carcinoma, grade 2, with a 10 % component of intermediate-grade ductal carcinoma in situ; all surgical margins were free, and sentinel lymph node evaluation was negative (0/3).

Biopsy confirmed invasive ductal carcinoma, grade 2. Hormone-receptor testing showed estrogen receptor 8/8 and progesterone receptor 7/8, while HER2 was scored as 1 and Ki-67 was 15 %. Imaging and metastatic workup findings were not documented in the form.

The MDT recommended chemotherapy with a taxane-based regimen for 4 cycles, noting that the patient is staged as T2N0 with perineural invasion positive and that Oncotype DX testing is unavailable. Post-chemotherapy, the plan includes postoperative radiotherapy and adjuvant aromatase inhibitor therapy combined with Zometa administered every 6 months.

تحريرا في ,

التاريخ :	23-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لدعـم صحة المرأة المصرية

07/08/2026

MDT FORM

Name:	Sohir, السيد عبدالوهاب البرلوي	**MRN:**	10831
Age:	61 Y	**ID:**	
Menopausal Status:		**Phone:**	01153459012
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	+VE
CO Morbidity:	FREE	**Reason Of MDT:**	NEW CASE

Clinical Data:

BX: RT IDC G2 /// LT FIBROADENOMA SURROUNDED WITH UDH

ER: 8\8 **PR:** 7\8 **HER2:** 1 **KI67:** 15

Sonomammography:

SM
RT BREAST UOQ POST THIRD IRREGULAR SPECULATED MASS WITH DISTORTION
NO MICROCALCIFICATIONS
UOQ ANT. THIRD CIRCUMSCRIBED OVAL MASS
10 OCLOCK POST THIRD 5 CM DEEP TO SKIN IRREGULAR SPICULATED HYPOECHOIC SOLID MASS 1.8*1.6 CM
NON SPECIFIC LN
LT BREAST UIQ OVAL MASS LESIONS 0.6*0.4 CM , 0.7*0.4 CM & 0.8*0.4 CM
NON SPECIFIC LN

Mets Workup:

CT CAP FREE

History:

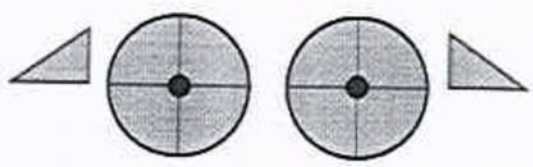
Recommendations:

FOR RT BCS+SLNB

MDT Outcome & Plan

Review mammosonography films at surgery clinic then proceed with Rt WLE & SLNB as well as Lt lumpectomy.

R L



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د شيماء وائس	د اميره جبري				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient's Name:	SOHIER AL SAYED
Date:	2026-04-01
Referred by:	Prof.Dr.
Hospital:	Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 60-year-old female with positive family history (sister), complaining of right breast lump of two months duration.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, posterior third , irregular speculated high density mass lesion with distortion yet no suspicious microcalcifications.
- UOQ, anterior third circumscribed oval equal density mass lesion.
- **Ultrasound** demonstrated 10 o'clock, posterior third 5m deep to the skin, irregular spiculated heterogenous hypoechoic solid mass lesion with surrounding echogenic halo, posterior acoustic shadowing and mild internal vascularity on color Doppler study measuring18 x 16 mm.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary lymph nodes.

Left breast.

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- UIQ mddle third circumscribed oval equal density mass lesions
- **Ultrasound** demonstrated 11 o'clock three circumscribed oval equal density mass lesions measuring 6 x 4 mm, 7 x 4 mm & 8 x 4 mm. No suspicious masses.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 5): UOQ suspicious solid mass lesion and another middle third probably benign solid mass lesion.

Left breast (BIRADS 3): UIQ three probably benign soli dmass lesions.

Recommendation:-

For biopsy and histopathological correlation.

Best Regards,

DR. Amal Hegazi, M.Sc.

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سهير السيد عبد الوهاب البزاوى	Request No.	: 13)05922
Patient No.	: 26506171601401	Request Date	: 18 04/2026
Path No.	: 1041/26	Verification Date	: 09 05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مؤدره
Age	: 60 Y	Department	: Ou t Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Righ breast UOQ mass
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy.

Technique:
- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultraview HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5) and Ki67 clone (30-9).

Results:
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 60 %tumor cells (7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10 % tumor cells (score 1+).
- Ki67:15 %

Conclusion:
Right breast cancer, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade 2
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 7/8).
- Her2: Low (score1+).
- Ki67:15 %

* Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0,

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egy pt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	الأستاذه / سهير السيد عبد الوهاب البزاوى	Request No.	13(05922
Patient No.	26506171601401	Request Date	18/)4/2026
Path No.	1041/26	Verification Date	09/05/2026
Sex	Female	Financial Category	جوستاف روسي - مبادره
Age	60 Y	Department	Out Patient
Referreing Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

no staining; 1, >1% 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells.IHC 0+:as defined as incomplete membrane reaction in less than 10 % of tumor cells . IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Signature
Prof Dr.Maha Guimei
Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :
Dr Maha Guimie

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سهير السيد عبد الوهاب البزاوى	Request No.	: 13005922
Patient No.	: 26506171601401	Request Date	: 18/04/2026
Path No.	: 1041/26	Verification Date	: 09/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - مبادره
Age	: 60 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data
Right UOQ &Left UIQ breast lesions.

Nature of specimen
1) Left breast lesion: Tru cut biopsy, collected on 18/4/2026, at 2: 10 p.m , cold ischemia time ois 10 seconds.
2) Right breast lesion , tru cut biopsy, collected on 18/4/2026, at 2: 20 p.m , cold ischemia time ois 10 seconds.

Gross examination
1) Left breast lesion,: Four grayish white tissue cores raning in size from 0.5 cm up to 1.5 cm, totally submitted.
2) Right breast mass: Fragmented grey white tissue cores raning in size from 0.2 cm up to 1.5 cm, totally submiited.

Microscopic examination
1-Left breast
Histopathological examination reveals fragmented pieces of a fibroadenoma surrounded areasof adenosis and UDH (usual ductal hyperplasia

2-Right breast
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade: 2 (differentiation 3+nuclear pleomorphism2+ mitosis2)
* DCIS: Absent.
* Angioinvasion: Absent
*Perineural invasion: Absent.

DIAGNOSIS

Verified by :
Dr Maha Guimie

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name	: الأستاذه / سهير السيد عبد الوهاب البزاوى	Request No.	: 13005922
Patient No.	: 26506171601401	Request Date	: 18/04/2026
Path No.	: 1041/26	Verification Date	: 09/05/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي مبادره
Age	: 60 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

1)Left breast lesion, tru cut biopsy:
-Fibroadenoma (minimally represented)

2) Right breast mass, Tru cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 2 .
For further IHC (ER, PR, HER2, Ki67)

Signature
Prof Dr. Maha Guimei
Dr.Heba Hassan Adly

Verified by :
Dr Maha Guimie

CAP ACCREDITED
غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

جوستاف روسي

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

08/30/2026

MDT FORM

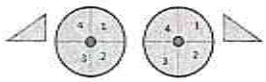
Name:	Sohir. السيد عبدالوهاب البزاري	**MRN:**	10831
Age:	61 Y	**ID:**	26506171601401
Menopausal Sta		**Phone:***	01029838424
NRS SCORE:		**Marital Status:**	
BMI:		**Family History:**	
Gender			
CO Morbidity:		**Reason Of MDT:**	POST OP
Surgical History:*	APPENDECTOMY D&C	**ECOG Performance Status**	○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4

Clinical Data:

BX: IDC G2

ER: 8/8 **PR:** 7/8 **HER2:** 1 **KI67:** 15

R L



T N M

History:

POST RT UPFRONT BCS+SLN
INVASIVE BREAST CARCINOMA G 2
10% DCIS INTERMEDIATE GRADE
FREE ALL MARGINS
SLN 0/3

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

TC 4 cycles AS PATIENT is T2NO with PNI positive and unavailability of Oncotype DX
PORT
Adjuvant AI +Zometa every 6 months

	Right Side				Left Side			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د نرمين مصطفى	د محمد تيراوي		